Sở Y tế: **Sở Y tế TP. Hà Nội** . . . . . **BỆNH ÁN NỘI KHOA** MS: 01/BV-01

Bệnh viện: **Bệnh viện Bạch Mai** . . . . . Số lưu trữ: **2026-004819** . . . . . .

Khoa: **Nội Tim Mạch** . . . . . Giường: **12** Mã YT: **010/2026/009481** . . . . . .

I. HÀNH CHÍNH:

1. Họ và tên *(In hoa)*: **NGUYỄN VĂN MINH** . . . . . 2. Sinh ngày: **1 5 0 8 1 9 6 8** Tuổi: **5 8**

3. Giới: 1. Nam [X] 2. Nữ [ ] 4. Nghề nghiệp: **Kỹ sư xây dựng** **0 4**

5. Dân tộc: **Kinh** . . . . . **0 1** 6. Ngoại kiều: **Không** . . . . . [ ][ ]

7. Địa chỉ: Số nhà: **45A** Thôn, phố: **Phố Giải Phóng** Xã, phường: **Phường Phương Mai**

Huyện (Q, Tx): **Quận Đống Đa** . . . . . **0 6** Tỉnh, thành phố: **Thành phố Hà Nội** **0 1**

8. Nơi làm việc: **Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà** . . . . . 9. Đối tượng: 1.BHYT [X] 2.Thu phí [ ] 3.Miễn [ ] 4.Khác [ ]

10. BHYT giá trị đến ngày: **31/12/2026** Số thẻ BHYT: **DN 4 01 01 23456789**

11. Họ tên, địa chỉ người nhà khi cần báo tin: **Nguyễn Thị Lan (Vợ) - 45A Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội** . . . . . Điện thoại số: **0912345678**

II. QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH:

12. Vào viện: **08** giờ **30** ph, ngày **10/10/2026**

13. Trực tiếp vào: 1.Cấp cứu [ ] 2.KKB [X] 3.Khoa ĐTr [ ]

14. Nơi giới thiệu: 1.CQ y tế [X] 2.Tự đến [ ] 3.Khác [ ]

- Vào viện do bệnh này lần thứ: **2**

	Khoa	Giờ / Ngày	Số ngày ĐTr
15. Vào khoa	**C1 - Tim Mạch**	09h15 10/10/2026	**1 0**
16. Chuyển		....h.... ..../..../....	[ ][ ]
Khoa		....h.... ..../..../....	[ ][ ]
		....h.... ..../..../....	[ ][ ]

17. Chuyển viện: 1.Tuyến trên [ ] 2.Tuyến dưới [ ] 3.CK [ ]

- Chuyển đến: . . . . . .

18. Ra viện: **15** giờ **00** ngày **20/10/2026**

1.Ra viện [X] 2.Xin về [ ] 3.Bỏ về [ ] 4.Đưa về [ ]

19. Tổng số ngày điều trị: **10** . . . . . **1 0** [ ]

III. CHẨN ĐOÁN **MÃ**

20. Nơi chuyển đến: **Cơn đau thắt ngực không ổn định / Tăng huyết áp** **I 2 0 0**

21. KKB, Cấp cứu: **Theo dõi Hội chứng vành cấp / Tăng huyết áp độ 2** **I 2 4 9**

22. Khi vào khoa điều trị: **Đau thắt ngực không ổn định - Tăng huyết áp độ 2 - Rối loạn lipid máu** **I 2 0 0**

+ Thủ thuật: [X] + Phẫu thuật: [ ]

MÃ

23. Ra viện:

+ Bệnh chính: **Đau thắt ngực không ổn định đã đặt Stent ĐMV phải (RCA)** **I 2 0 0**

+ Bệnh kèm theo: **Tăng huyết áp độ 2, Rối loạn chuyển hóa lipoprotein** **I 1 0** [ ]

+ Tai biến: [ ] + Biến chứng: [ ]

IV. TÌNH TRẠNG RA VIỆN:

24. Kết quả điều trị:

1. Khỏi [ ] 4. Nặng hơn [ ]
2. Đỡ, giảm [X] 5. Tử vong [ ]
3. Không thay đổi [ ]

25. Giải phẫu bệnh *(khi có sinh thiết)*:

1. Lành tính [ ] 2. Nghi ngờ [ ] 3. Ác tính [ ]

26. Tình hình tử vong: .... giờ .... ph, ngày ..../..../.....

1. Do bệnh [ ] 2. Do tai biến ĐTr [ ] 3. Khác [ ]
1. Trong 24 giờ vào viện [ ] 2. Sau 24 giờ vào viện [ ]

27. Nguyên nhân chính tử vong: . . . . . [ ][ ][ ][ ]

28. Khám nghiệm tử thi: [ ] 29. CĐ GP tử thi: . . . . . [ ][ ][ ][ ]

Ngày 20 tháng 10 năm 2026

Giám đốc bệnh viện
Họ và tên: **PGS.TS. Đào Xuân Cơ**

Trưởng khoa
Họ và tên: **TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài**

A- BỆNH ÁN

I. Lý do vào viện: Đau ngực trái lan lên vai và tay trái . . . . . Vào ngày thứ: **02** của bệnh

II. Hỏi bệnh:

1. Quá trình bệnh lý: *(khởi phát, diễn biến, chẩn đoán, điều trị của tuyến dưới v.v...)*

Cách vào viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện từng cơn đau ngực sau xương ức kiểu đè ép, lan lên vai trái và mặt trong cánh tay trái, mỗi cơn kéo dài khoảng 15-20 phút, kèm vã mồ hôi, khó thở nhẹ khi gắng sức. Sáng nay cơn đau tăng lên ngay cả khi nghỉ ngơi nên người nhà đưa vào viện khám và nhập viện. . . . . .

2. Tiền sử bệnh:

+ Bản thân: *(phát triển thể lực từ nhỏ đến lớn, những bệnh đã mắc, phương pháp ĐTr, tiêm phòng, ăn uống, sinh hoạt...)*

Phát hiện Tăng huyết áp 5 năm nay, điều trị Amlodipin 5mg/ngày nhưng uống không đều. Rối loạn mỡ máu 2 năm. . . . . .

Đặc điểm liên quan bệnh:

TT	Ký hiệu	X	Thời gian (tháng)	TT	Ký hiệu	X	Thời gian (tháng)
01	- Dị ứng		(dị nguyên)	04	- Thuốc lá	X	120
02	- Ma tuý			05	- Thuốc lào		
03	- Rượu bia	X	60	06	- Khác		

+ Gia đình: *(Những người trong gia đình: bệnh đã mắc, đời sống, tinh thần, vật chất v.v...)*

Bố ruột mắc bệnh Tăng huyết áp và Tai biến mạch máu não năm 68 tuổi. . . . . .

III. Khám bệnh:

1. Toàn thân: *(ý thức, da niêm mạc, hệ thống hạch, tuyến giáp...)*

Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt (Glasgow 15 điểm).
Da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da.
Tuyến giáp không to, hạch ngoại vi không sờ thấy.

Mạch: **88** lần/ph
Nhiệt độ: **36.8** °C
Huyết áp: **155/95** mmHg
Nhịp thở: **19** lần/ph
Cân nặng: **68** kg

2. Các cơ quan:

+ Tuần hoàn: Mỏm tim đập ở khoang liên sườn V đường trung đòn trái. Nhịp tim đều, tần số 88 chu kỳ/phút, T1 T2 rõ, không nghe thấy tiếng thổi bệnh lý. . . . . .
+ Hô hấp: Lồng ngực hai bên cân đối, di động theo nhịp thở. Rì rào phế nang êm dịu hai phế trường, không có rales. . . . . .
+ Tiêu hoá: Bụng mềm, không chướng, gan lách không sờ thấy, không có điểm đau khu trú. . . . . .
+ Thận - Tiết niệu - Sinh dục: Chạm thận (-), bập bềnh thận (-), tiểu tiện tự chủ, nước tiểu vàng trong. . . . . .
+ Thần kinh: Hội chứng màng não (-), không có dấu hiệu thần kinh khu trú. . . . . .
+ Cơ - Xương - Khớp: Các khớp vận động trong giới hạn bình thường, không sưng nóng đỏ đau. . . . . .
+ Tai - Mũi - Họng: Chưa phát hiện biểu hiện bệnh lý. . . . . .
+ Răng - Hàm - Mặt: Chưa phát hiện biểu hiện bệnh lý. . . . . .
+ Mắt: Hai mắt nhìn rõ, kết mạc không vàng. . . . . .
+ Nội tiết, dinh dưỡng và các bệnh lý khác: Chưa phát hiện bất thường. . . . . .

3. Các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm: - Điện tâm đồ 12 chuyển đạo, Siêu âm Doppler tim, X-quang tim phổi thẳng.
- Sinh hóa máu: Troponin T hs, CK-MB, Pro-BNP, Glucose, Ure, Creatinin, Bộ mỡ máu (Cholesterol, Triglycerid, HDL-C, LDL-C), Điện giải đồ.
- Công thức máu, Đông máu cơ bản, Chụp mạch vành qua da (DSA). . . . . .

4. Tóm tắt bệnh án: Bệnh nhân nam 58 tuổi, tiền sử Tăng huyết áp 5 năm, hút thuốc lá 10 năm, vào viện ngày thứ 2 của bệnh vì đau ngực trái kiểu mạch vành. Qua hỏi bệnh và thăm khám phát hiện:
- Hội chứng vành cấp: Đau ngực sau xương ức từng cơn 15-20 phút, lan vai trái.
- Huyết áp lúc vào 155/95 mmHg, nhịp tim 88 lần/phút.
- Các cơ quan khác hiện chưa phát hiện dấu hiệu bệnh lý cấp tính. . . . . .

IV. Chẩn đoán khi vào khoa điều trị:

+ Bệnh chính: **Đau thắt ngực không ổn định** . . . . . .
+ Bệnh kèm theo *(nếu có)*: **Tăng huyết áp độ 2 - Rối loạn lipid máu** . . . . . .
+ Phân biệt: **Nhồi máu cơ tim không ST chênh lên (NSTEMI)** . . . . . .

V. Tiên lượng: Dè dặt, nguy cơ hẹp nặng động mạch vành cần can thiệp đặt Stent. . . . . . .

VI. Hướng điều trị: Kháng kết tập tiểu cầu kép (Aspirin + Clopidogrel), Statin liều cao, ức chế Beta, ức chế men chuyển, chụp và can thiệp động mạch vành qua da. . . . . . .

Ngày 10 tháng 10 năm 2026
Bác sỹ làm bệnh án

Họ và tên: **ThS.BS. Lê Hoàng Nam**

B. TỔNG KẾT BỆNH ÁN

1. Quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng:
Bệnh nhân vào viện với tình trạng đau thắt ngực không ổn định, huyết áp 155/95 mmHg. Sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng và chụp DSA động mạch vành phát hiện hẹp 85% đoạn II động mạch vành phải (RCA). Bệnh nhân đã được can thiệp nong và đặt 01 Stent phủ thuốc tại RCA ngày 12/10/2026. Sau can thiệp bệnh nhân hết đau ngực, huyết động ổn định (HA 125/75 mmHg, mạch 70 lần/phút).

2. Tóm tắt kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán:
- Điện tâm đồ: ST chênh xuống 1.5mm ở DII, DIII, aVF.
- Troponin T hs: 18 ng/L (không động học tăng cấp); LDL-C: 4.2 mmol/L.
- Siêu âm tim: EF 62%, giảm động nhẹ thành dưới thất trái.
- Chụp ĐMV (DSA): Hẹp 85% RCA đoạn II, đã đặt 01 DES RCA dòng chảy TIMI 3.

3. Phương pháp điều trị:
Can thiệp đặt 01 Stent phủ thuốc động mạch vành phải (RCA) kết hợp điều trị nội khoa: Dual Antiplatelet (Aspirin 81mg + Brilinta 90mg x 2v), Rosuvastatin 20mg, Bisoprolol 2.5mg, Perindopril 5mg.

4. Tình trạng người bệnh ra viện:
Bệnh nhân tỉnh táo, hết hoàn toàn triệu chứng đau ngực, khó thở. Mạch 68 lần/phút, HA 120/75 mmHg, vị trí chọc mạch quay phải khô, lành tốt.

5. Hướng điều trị và các chế độ tiếp theo:
- Uống thuốc đều hàng ngày theo đơn ngoại trú tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc kháng kết tập tiểu cầu.
- Kiêng thuốc lá, rượu bia, hạn chế mỡ động vật, ăn nhạt.
- Tái khám sau 1 tháng tại Phòng khám Tim mạch hoặc khám lại ngay nếu đau ngực tái phát.

Hồ sơ, phim, ảnh		**Người giao hồ sơ:**	*Ngày 20 tháng 10 năm 2026*
Loại	**Số tờ**	Họ tên: ĐD. Trần Thị Mai	**Bác sỹ điều trị**
- X - quang	01	**Người nhận hồ sơ:**	
- CT Scanner	00		
- Siêu âm	02		
- Xét nghiệm	06		
- Khác: Đĩa CD DSA	01		
- Toàn bộ hồ sơ	18	Họ tên: CN. Phạm Văn Hùng	Họ tên: **ThS.BS. Lê Hoàng Nam**